Estilo UERJ

Simulado R03 Caderno

Simulado de revisão no formato da UERJ, montado a partir dos seus erros nos Simulados 1 a 4: quatro alternativas e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 59 anos, hipertenso em uso de anlodipino, refere lombalgia mecânica há 3 meses, sem perda de peso e sem déficit neurológico. A RM da coluna toracolombar mostra lesão lítica única no corpo vertebral de T11, com componente de partes moles e sem compressão do canal. A biópsia guiada por TC revela infiltrado de plasmócitos monotípicos kappa. Hb 13,6 g/dL, cálcio 9,3 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL. Eletroforese de proteínas com pico de 0,5 g/dL, imunofixação IgG kappa, relação kappa/lambda das cadeias livres de 2,8. O inventário radiográfico do esqueleto (crânio, ossos longos, bacia e coluna) não mostra outras lesões. Aspirado e biópsia de crista ilíaca: plasmócitos clonais em 5% por citometria de fluxo. O radioterapeuta já agendou o planejamento. O próximo passo mais adequado é:

A) PET-CT com FDG de corpo inteiro

B) Cintilografia óssea com tecnécio

C) Indução com bortezomibe e transplante autólogo

D) Radioterapia local em dose curativa

---

2 Mulher de 71 anos, hipertensa em uso de hidroclorotiazida, chega à emergência com dor torácica opressiva iniciada 1 hora após receber a notícia da morte do neto. ECG: supradesnivelamento do segmento ST de V2 a V5. A coronariografia de emergência mostrou placas de 30% na descendente anterior, sem lesão obstrutiva nem trombo, e a ventriculografia, acinesia dos segmentos médios e apicais com hipercinesia basal. Duas horas depois, na unidade coronariana: PA 78 × 50 mmHg, FC 114 bpm, extremidades frias, sonolenta, pulmões limpos à ausculta, sopro sistólico 3+/6 novo na borda esternal esquerda. Lactato 3,6 mmol/L, troponina I 2,4 ng/mL. Ecocardiograma à beira do leito: FE de 35%, gradiente intraventricular de 80 mmHg com movimento sistólico anterior da mitral, insuficiência mitral moderada e veia cava inferior de 12 mm com colapso inspiratório. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Angioplastia da descendente anterior

B) Expansão volêmica e betabloqueador de curta ação

C) Nitroglicerina venosa e furosemida

D) Dobutamina em infusão contínua

---

3 Homem de 31 anos, tabagista de 10 maços-ano, foi submetido há 4 meses a orquiectomia por tumor de células germinativas não seminomatoso com metástases retroperitoneais e recebeu 3 ciclos de bleomicina, etoposídeo e cisplatina, o último há 6 semanas, com dexametasona como antiemético em todos os ciclos. Há 3 semanas tem tosse seca e dispneia progressiva, hoje aos pequenos esforços, sem febre. Exame: FR 24 irpm, FC 96 bpm, SatO2 93% em repouso e 85% ao caminhar, estertores finos em ambas as bases. Leucócitos 6.800/mm³ (linfócitos 1.100/mm³), DHL 410 U/L (referência até 250); alfafetoproteína e beta-hCG normalizados. DLCO de 41% do previsto (antes da quimioterapia: 88%). TC de tórax: reticulação e opacidades em vidro fosco subpleurais, predominando nas bases, com bandas parenquimatosas, sem nódulos, sem cistos e sem derrame. O diagnóstico e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Pneumocistose / sulfametoxazol-trimetoprima

B) Pneumonite por bleomicina / prednisona

C) Metástases pulmonares / quimioterapia de resgate

D) Tromboembolismo pulmonar / anticoagulação

---

4 Homem de 63 anos, tabagista de 50 maços-ano, encaminhado com diagnóstico de 'miastenia gravis soronegativa' por dificuldade para subir escadas e levantar-se da cadeira há 4 meses, com piora discreta no fim do dia e ptose leve bilateral. Refere boca seca intensa, constipação e disfunção erétil surgidas no mesmo período. Iniciou piridostigmina há 3 semanas, com melhora mínima. Anticorpos antirreceptor de acetilcolina e anti-MuSK negativos; CPK 140 U/L (referência até 190); TSH normal. Exame: força grau 4 menos em cinturas pélvica e escapular, musculatura ocular extrínseca livre, reflexos patelares e aquileus abolidos que surgem após 10 segundos de contração voluntária máxima do quadríceps, sensibilidade preservada. Radiografia de tórax: alargamento hilar direito. Na eletroneuromiografia, o achado esperado é:

A) CMAP basal baixo, com incremento após esforço

B) CMAP basal normal, com decremento a 3 Hz

C) Potenciais motores breves e polifásicos

D) Condução lenta, com bloqueio de condução

---

5 Homem de 24 anos, com diabetes tipo 1, foi admitido em cetoacidose após 2 dias sem insulina: glicemia 486 mg/dL, pH 7,08, bicarbonato 7 mEq/L, sódio 132 mEq/L, cloreto 96 mEq/L, beta-hidroxibutirato 6,2 mmol/L. Recebeu 6 L de solução salina a 0,9% nas primeiras 10 horas, insulina regular em infusão contínua e cloreto de potássio. Agora está lúcido, aceita dieta e não vomita. PA 124 × 78 mmHg, FC 88 bpm. Exames atuais: glicemia 212 mg/dL, pH venoso 7,31, bicarbonato 16 mEq/L, sódio 140 mEq/L, cloreto 116 mEq/L, potássio 4,0 mEq/L, beta-hidroxibutirato 0,4 mmol/L, lactato 1,1 mmol/L, creatinina 0,9 mg/dL. O residente propõe manter a insulina venosa até o bicarbonato passar de 18 mEq/L. O distúrbio que explica o bicarbonato baixo e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Cetoacidose persistente / manter insulina venosa

B) Hiperclorêmica / insulina subcutânea com sobreposição

C) Acidose láctica / mais volume e antibiótico

D) Hiperclorêmica / bicarbonato e insulina venosa

---

6 Mulher de 29 anos, com nefrite lúpica classe IV diagnosticada há 6 semanas, recebeu pulsoterapia com metilprednisolona e está em prednisona 60 mg/dia e micofenolato 2 g/dia. Natural da zona rural do Vale do Jequitinhonha (MG), trabalhou descalça na lavoura até os 18 anos. Há 5 dias tem dor abdominal difusa, vômitos e diarreia; há 2 dias, tosse com escarro hemoptoico e dispneia; hoje febre de 39,2 °C, cefaleia e rigidez de nuca. PA 96 × 58 mmHg, FC 122 bpm, SpO2 de 89%. Leucócitos 18.400/mm³ com 0% de eosinófilos, Hb 9,8 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, creatinina 1,1 mg/dL (era 2,0 no diagnóstico), C3 e C4 normais e anti-DNA que caiu de 1:640 para 1:40. TC de tórax com infiltrado alveolar bilateral. Líquor: 1.200 células/mm³, 90% de neutrófilos, Gram com bacilos Gram-negativos; hemoculturas com Escherichia coli. Além da antibioticoterapia, a conduta mais adequada é:

A) Pulsoterapia com metilprednisolona

B) Ivermectina e redução do corticoide

C) Albendazol e manutenção do corticoide

D) Ciclofosfamida e plasmaférese

---

7 Homem de 45 anos recebeu há 3 semanas o diagnóstico de HIV, com CD4 de 48 células/mm³ e carga viral de 380.000 cópias/mL, e ainda não iniciou TARV. Há 6 semanas evolui com perda de força progressiva no dimídio esquerdo, dificuldade para enxergar à esquerda e fala arrastada, sem febre, sem cefaleia e sem rebaixamento de consciência. Ao exame, hemiparesia esquerda grau 4, hemianopsia homônima esquerda e disartria, sem rigidez de nuca. A sorologia IgG para toxoplasmose é reagente; antígeno criptocócico sérico negativo; teste rápido molecular para tuberculose no escarro não detectado. RM de crânio: lesões hiperintensas em T2 e FLAIR na substância branca subcortical parieto-occipital direita, envolvendo as fibras em U, sem realce pelo gadolínio e sem efeito de massa. Líquor: 3 células/mm³, proteína 52 mg/dL, glicose normal, VDRL não reagente e PCR para vírus JC positiva. O residente lembra que, na meningite criptocócica, a TARV é adiada pelo risco de síndrome inflamatória de reconstituição imune. Quanto ao início da TARV e ao tratamento antiviral específico, respectivamente, a conduta mais adequada é:

A) Adiar por 4 a 6 semanas / cidofovir

B) Adiar por 4 a 6 semanas / nenhum

C) Iniciar em até 2 semanas / cidofovir

D) Iniciar em até 2 semanas / nenhum

---

8 Homem de 52 anos, tratado de tumor de testículo com 4 ciclos de cisplatina há 3 anos e em remissão, foi submetido a colectomia total com ileostomia por retocolite ulcerativa há 8 meses. O débito da ileostomia está entre 1,8 e 2,2 litros por dia. Há 2 semanas tem câimbras e parestesias periorais. Usa mesalazina; nega diurético, inibidor de bomba de prótons e álcool. PA 112 × 70 mmHg, FC 96 bpm, sinal de Trousseau positivo. Exames: Na 136 mEq/L, K 3,1 mEq/L, cálcio total 7,6 mg/dL (albumina 4,0 g/dL), Mg 0,9 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 18 pg/mL (15 a 65), creatinina 1,0 mg/dL. Na urina de 24 horas, magnésio de 6 mg, com fração de excreção de magnésio calculada em 0,8%. A causa mais provável da hipomagnesemia é:

A) Síndrome de Gitelman de expressão tardia

B) Toxicidade tubular pela mesalazina

C) Tubulopatia residual pela cisplatina

D) Perda intestinal pela ileostomia de alto débito

---

9 Homem de 61 anos, diabético, ex-tabagista (parou há 8 anos), encaminhado por eritrocitose. Usa metformina e, há 4 meses, empagliflozina; não usa testosterona. Hemograma de 2 anos atrás: hematócrito de 43%. Assintomático, sem prurido aquagênico, sem eritromelalgia, sem roncos ou sonolência diurna. Exame: PA 138 × 84 mmHg, pletora facial discreta, baço e fígado não palpáveis, sem massas abdominais. Exames: Hb 19,1 g/dL, hematócrito 57%, leucócitos 7.200/mm³, plaquetas 248.000/mm³, eritropoetina sérica 54 mUI/mL (referência: 4 a 26), JAK2 V617F negativo, SpO2 96% em ar ambiente e carboxi-hemoglobina 1,1%. Ao revisar o prontuário, o residente encontra hematócrito de 52% num exame de rotina colhido um mês antes de iniciar a empagliflozina. Creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 sem hematúria. A conduta mais adequada agora é:

A) Pesquisar mutação no éxon 12 do JAK2

B) Medir a P50 da hemoglobina

C) Tomografia de abdome com contraste

D) Suspender a empagliflozina e repetir em 3 meses

---

10 Homem de 38 anos, natural de Lábrea (AM), mora no Rio de Janeiro há 2 anos e é encaminhado por plaquetopenia achada em exame admissional. Sabe ter HBsAg reagente há 10 anos e foi rotulado em outro serviço como portador inativo, sem tratamento. Bebe duas latas de cerveja por semana, nega drogas injetáveis e transfusões; IMC de 24 kg/m², sem diabetes. Ao exame, PA 118/74 mmHg, aranhas vasculares no tórax e baço palpável a 3 cm do rebordo costal, sem ascite. Exames: ALT 96 U/L e AST 88 U/L (referência até 41), plaquetas 98.000/mm³, albumina 3,6 g/dL, INR 1,2, bilirrubina total 1,1 mg/dL. HBeAg não reagente, anti-HBe reagente, HBV-DNA indetectável (limite de detecção de 10 UI/mL), anti-HCV e anti-HIV não reagentes, ferritina 240 ng/mL. Elastografia hepática transitória: 14,8 kPa. Ultrassonografia: fígado de contornos irregulares, sem nódulos, veia porta pérvia. A interpretação do HBV-DNA indetectável e o próximo exame mais adequado são, respectivamente:

A) Infecção crônica inativa / HBV-DNA em 6 meses

B) Supressão pelo vírus delta / anti-HDV total

C) Mutante pré-core / sequenciamento do HBV

D) Hepatopatia não viral / FAN e IgG séricos

---

11 Mulher de 44 anos foi submetida a ressecção transesfenoidal de macroadenoma não funcionante de 2,8 cm. Nas primeiras 48 horas, teve diurese de 5,5 L/dia, osmolalidade urinária de 110 mOsm/kg e sódio de 147 mEq/L, e passou a receber desmopressina 0,1 mg via oral de 12 em 12 horas, mantida na prescrição de alta no 4º dia, com sódio de 140 mEq/L. Cortisol sérico às 8 horas no 3º dia: 17 µg/dL, sem glicocorticoide desde a cirurgia. No 8º dia, comparece ao retorno ambulatorial assintomática; bebe cerca de 3 L de água por dia, por orientação de manter-se hidratada. PA 118 × 74 mmHg, sem edema ou sinais de desidratação. Sódio 126 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, osmolalidade plasmática 262 mOsm/kg, osmolalidade urinária 540 mOsm/kg, sódio urinário 68 mEq/L, glicemia e TSH normais. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Manter a desmopressina e associar tolvaptana

B) Solução salina a 3% em bolus

C) Hidrocortisona em dose de estresse

D) Suspender a desmopressina e restringir água

---

12 Homem de 61 anos, hipertenso controlado com losartana, sem antecedente de febre reumática, procura atendimento por dispneia aos esforços moderados que piorou nos últimos 8 meses. Ecocardiograma feito há 4 anos, em exame admissional, descreveu prolapso do folheto posterior da valva mitral com refluxo discreto; não voltou ao cardiologista. Nega angina e síncope. Ao exame: PA 134 × 78 mmHg, FC 76 bpm, rítmico; pulso carotídeo de ascensão rápida e amplitude normal; ictus no 6º espaço intercostal, na linha axilar anterior, propulsivo, com duas polpas digitais. Sopro sistólico 4+/6, que começa junto com a B1 e se mantém em platô até a B2, mais audível na borda esternal esquerda alta e no foco aórtico, com irradiação para as carótidas; B1 hipofonética. ECG: ritmo sinusal, sem sobrecarga ventricular esquerda com strain. Além do sopro descrito, espera-se encontrar na ausculta, quanto à bulha extra e ao comportamento da B2, respectivamente:

A) Quarta bulha / B2 única

B) Terceira bulha / desdobramento amplo de B2

C) Quarta bulha / desdobramento paradoxal de B2

D) Estalido de abertura / B1 hiperfonética

---

13 Homem de 52 anos, jateador de areia em estaleiro por 22 anos, com silicose diagnosticada há 6 anos (nódulos centrolobulares e conglomerados nos lobos superiores), tabagista de 30 maços-ano, procura atendimento por tosse produtiva há 2 meses, perda de 5 kg e febre baixa vespertina. Nega hemoptise. Ao exame, FR 20 irpm, SpO2 94% em ar ambiente, emagrecido, sem linfonodos periféricos palpáveis. A TC comparada com a de 1 ano atrás mostra aumento de um conglomerado no lobo superior direito, que agora tem área de escavação central. O médico que o acompanha solicitou PET-CT, cujo laudo descreve "lesão hipermetabólica no lobo superior direito (SUVmax 9,4) e linfonodos mediastinais e hilares hipermetabólicos (SUVmax 6,1), achados suspeitos de neoplasia". Escarra com facilidade pela manhã, mas nenhuma amostra de escarro foi colhida até agora. Hemograma com leucócitos de 9.800/mm³ e PCR de 46 mg/L. O próximo exame mais adequado é:

A) Ecobroncoscopia com punção linfonodal

B) Teste rápido molecular e cultura no escarro

C) Biópsia transtorácica guiada por TC

D) Lobectomia superior direita diagnóstica

---

14 Mulher de 41 anos, com esclerose sistêmica cutânea difusa diagnosticada há 8 meses, escore de Rodnan de 28 e anti-RNA polimerase III reagente, iniciou há 4 semanas prednisona 40 mg/dia por miosite sobreposta. Há 3 dias tem cefaleia e visão turva. PA 186 × 112 mmHg (habitual de 100 × 60), FC 96 bpm, sem febre, sem alteração do nível de consciência. Hb 8,1 g/dL, plaquetas 72.000/mm³, esquizócitos em 3% das hemácias, LDH 980 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo. Creatinina 2,4 mg/dL (0,7 há 1 mês), proteinúria 1+ e hematúria discreta. Atividade da ADAMTS13 de 48% (referência: 60 a 130%). Fundo de olho com hemorragias em chama de vela e exsudatos algodonosos. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

A) Crise renal esclerodérmica / captopril em doses crescentes

B) Púrpura trombocitopênica trombótica / plasmaférese

C) Crise renal esclerodérmica / plasmaférese

D) Púrpura trombocitopênica trombótica / captopril em doses crescentes

---

15 Mulher de 54 anos, previamente hígida, é trazida pelo marido com 3 dias de febre de 38,6 °C e cefaleia e, desde o dia anterior, comportamento estranho, queixa de 'cheiro de queimado' e uma crise focal com automatismos orais. Nega viagens, contato com animais e vacinação recente. Glasgow 14, desorientada, rigidez de nuca discreta, sem déficit motor. RM: hipersinal em FLAIR e restrição à difusão no lobo temporal medial e na ínsula à esquerda. Líquor, colhido nas primeiras 24 horas dos sintomas neurológicos: 18 células/mm³ (90% linfócitos), 6 hemácias/mm³, proteína 62 mg/dL, glicose 64 mg/dL (glicemia 110 mg/dL). Iniciou aciclovir IV na admissão. No segundo dia de internação, chega a PCR para herpes simples no líquor: negativa. EEG: descargas epileptiformes periódicas lateralizadas à esquerda. A conduta mais adequada é:

A) Suspender o aciclovir e observar

B) Manter o aciclovir e repetir a PCR

C) Trocar o aciclovir por ganciclovir

D) Pulsoterapia e painel de autoanticorpos

---

16 Mulher de 29 anos, bióloga, fez coleta de campo há 9 dias às margens de um rio em município do interior de São Paulo com grande população de capivaras; não lembra de picada. Há 6 dias tem febre de 39,5 °C, cefaleia intensa, mialgia difusa e náuseas. Na semana anterior à viagem limpou com o pai o porão da casa, que havia alagado, onde viu fezes de roedores. Ao exame, PA 100/60 mmHg, FC 112 bpm, sem sufusão conjuntival, panturrilhas indolores, exantema maculopapular que começou no 3º dia nos punhos e tornozelos e hoje atinge tronco, palmas e plantas, com petéquias nos membros inferiores. Plaquetas 78.000/mm³, sódio 129 mEq/L, AST 110 U/L, creatinina 1,3 mg/dL, CK 190 U/L (referência: até 170), bilirrubina total 0,9 mg/dL. A imunofluorescência indireta para Rickettsia rickettsii resultou IgG não reagente na amostra colhida hoje, no 6º dia de doença. A conduta mais adequada é:

A) Ceftriaxona e sorologia para leptospirose

B) Doxiciclina já e sorologia pareada em 14 dias

C) Aguardar a segunda amostra sem antibiótico

D) Teste NS1 e hidratação antes do antibiótico

---

17 Mulher de 58 anos, com transtorno bipolar em uso de carbonato de lítio há 22 anos, com litemias sempre entre 0,6 e 0,9 mEq/L e nenhum episódio de intoxicação, é encaminhada porque a creatinina subiu de 1,1 para 2,0 mg/dL em 6 anos. É hipertensa há 8 anos, em uso de anlodipino, com PA de 138 x 84 mmHg no consultório. Relata noctúria e sede, com ingestão de cerca de 4 litros de água por dia. Urina: densidade 1,004, sem hematúria, sem cilindros; proteinúria de 24 horas de 0,4 g. Fundoscopia com cruzamentos arteriovenosos patológicos e estreitamento arteriolar. Ultrassonografia: rins simétricos de 9,5 cm, com múltiplos microcistos corticais e medulares de 1 a 2 mm. A equipe solicita biópsia renal para embasar a discussão sobre a suspensão do lítio com o psiquiatra. O achado histológico mais provável é:

A) Infiltrado intersticial agudo com eosinófilos

B) Glomeruloesclerose segmentar e focal colapsante

C) Fibrose intersticial com microcistos tubulares distais

D) Nefroesclerose arteriolar hialina difusa

---

18 Homem de 69 anos, com melanoma metastático, recebeu a segunda dose de nivolumabe com ipilimumabe há 18 dias. Tem doença coronariana com stent na artéria descendente anterior há 3 anos, em uso de AAS, atorvastatina 40 mg e metoprolol; cintilografia de perfusão há 4 meses sem isquemia. Há 5 dias refere dor nas coxas, cansaço aos esforços leves e desconforto torácico em aperto, intermitente, e desde ontem visão dupla no fim do dia e pálpebras caídas. Exame: PA 112/70 mmHg, FC 58 bpm, SatO2 95%, ptose bilateral assimétrica, fraqueza proximal grau 4 nos quatro membros, pulmões limpos. ECG: bloqueio atrioventricular de primeiro grau e bloqueio de ramo direito, ambos novos, sem supradesnivelamento de ST. Troponina T ultrassensível 1.150 ng/L (referência até 14), CK 4.200 U/L, TSH normal. Ecocardiograma: fração de ejeção de 52%, sem alteração segmentar nova. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Suspender a imunoterapia e pulso de metilprednisolona

B) Cateterismo e dupla antiagregação plaquetária

C) Piridostigmina, mantendo a imunoterapia

D) Suspender a atorvastatina e hidratação venosa

---

19 Mulher de 19 anos, com diabetes tipo 1 há 6 anos, chega com vômitos há 3 dias, dor abdominal difusa e respiração de Kussmaul; vinha aplicando insulina apenas à noite. PA 96 × 58 mmHg, FC 124 bpm, sonolenta, mas obedece a comandos. Glicemia 538 mg/dL, pH 6,96, bicarbonato 4 mEq/L, ânion gap 28, sódio 131 mEq/L, potássio 3,1 mEq/L, fósforo 1,2 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL, beta-hidroxibutirato 7,8 mmol/L. ECG com ondas U discretas, sem arritmia. Já recebeu 1 L de solução salina a 0,9% na primeira hora. A plantonista prepara insulina regular em bolus de 0,1 U/kg seguida de infusão contínua, e o residente sugere bicarbonato de sódio por causa do pH abaixo de 7,0. Além de manter a hidratação, a conduta mais adequada neste momento é:

A) Bicarbonato e insulina em infusão contínua

B) Insulina em bolus e potássio em seguida

C) Insulina contínua junto com potássio venoso

D) Potássio venoso, insulina só após 3,5 mEq/L

---

20 Homem de 63 anos, operado de síndrome do túnel do carpo bilateral há 1 ano, relata dispneia progressiva e edema de membros inferiores há 6 meses, tontura ao levantar e perda de 6 kg. Era hipertenso e suspendeu por conta própria a anlodipina porque a pressão 'caiu sozinha'. Ao exame: PA 98 × 64 mmHg deitado e 78 × 50 mmHg em pé, FC 92 bpm, turgência jugular, hepatomegalia dolorosa, edema 3+/4 até a raiz das coxas, língua de bordos endentados. ECG: baixa voltagem nas derivações periféricas e ondas Q de V1 a V3. Ecocardiograma: septo de 16 mm com aspecto granular, FE de 50% e strain longitudinal reduzido na base com ápice preservado. NT-proBNP 6.800 pg/mL, troponina T 0,08 ng/mL (referência: até 0,014); creatinina 1,4 mg/dL, albumina 2,6 g/dL, proteinúria de 4,2 g/24 h. O exame a ser solicitado em seguida, o mais adequado neste momento, é:

A) Ressonância cardíaca com realce tardio

B) Sequenciamento do gene da transtirretina

C) Cadeias leves livres e imunofixação sérica e urinária

D) Cintilografia óssea com pirofosfato de tecnécio

---

21 Homem de 44 anos, com asma de início aos 38 anos e polipose nasal operada duas vezes, em uso de budesonida-formoterol, apresenta há 2 meses tosse e infiltrados pulmonares que mudam de lugar entre radiografias, com eosinófilos de 4.800/mm³ (34%). A pneumologia levantou aspergilose broncopulmonar alérgica: IgE total de 1.900 UI/mL e IgE específica para Aspergillus fumigatus de 0,9 kUA/L (referência: abaixo de 0,35). ANCA por imunofluorescência, anti-MPO e anti-PR3 não reagentes. Há 10 dias, dispneia aos pequenos esforços e edema de membros inferiores. PA 118 × 76 mmHg, FC 104 bpm, sem déficit neurológico. Troponina I de 0,9 ng/mL (referência: abaixo de 0,04), creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 normal. Ecocardiograma com fração de ejeção de 35% e hipocinesia difusa; coronariografia sem lesões; RM cardíaca com realce tardio subendocárdico difuso, de distribuição não coronariana. Além do glicocorticoide em dose alta, a conduta de indução mais adequada é:

A) Mepolizumabe 300 mg mensal

B) Itraconazol oral por 16 semanas

C) Ciclofosfamida intravenosa

D) Omalizumabe subcutâneo

---

22 Mulher de 34 anos, sem comorbidades, nunca engravidou e nunca recebeu transfusão. Há 6 dias tem fadiga, icterícia e urina escura, e desde ontem dispneia e opressão torácica ao caminhar até o banheiro. Exame: FC 132 bpm, PA 102 × 60 mmHg, SpO2 95%, icterícia 2+/4, palidez acentuada, baço palpável a 2 cm do rebordo. ECG com taquicardia sinusal e infradesnível de ST de 1 mm em V4 a V6; troponina discretamente elevada. Exames: Hb 4,4 g/dL, reticulócitos 16%, LDH 1.150 U/L, bilirrubina indireta 4,9 mg/dL, haptoglobina indetectável, esferócitos no esfregaço, Coombs direto IgG 4+ e C3d negativo. Recebeu metilprednisolona há 10 horas. O banco de sangue informa autoanticorpo pan-reativo no soro e no eluato, com prova cruzada incompatível com todas as unidades testadas, e que a técnica de adsorção para excluir aloanticorpo levará cerca de 24 horas. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Transfundir hemácias ABO e RhD compatíveis, lentamente

B) Plasmaférese de urgência antes de transfundir

C) Manter o corticoide e aguardar a adsorção

D) Imunoglobulina intravenosa sem transfusão

---

23 Homem de 52 anos, com leucemia mieloide aguda, está no 12º dia após indução com citarabina e daunorrubicina. Há 2 dias tem febre e está em uso de cefepima; hoje surgiram dor intensa em fossa ilíaca direita, distensão abdominal e diarreia aquosa, 5 episódios. Temperatura 38,7 °C, PA 108/66 mmHg, FC 112 bpm; abdome distendido, doloroso à palpação profunda da fossa ilíaca direita, sem defesa difusa e com ruídos diminuídos. Neutrófilos 80/mm³, plaquetas 18.000/mm³, lactato 1,8 mmol/L. TC de abdome: espessamento parietal do ceco e do cólon ascendente de 14 mm, com densificação da gordura pericecal, sem pneumoperitônio e sem coleção; apêndice com 6 mm de diâmetro, sem apendicolito. Hemoculturas em andamento; pesquisa de toxina de Clostridioides difficile solicitada, ainda sem resultado. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Apendicectomia videolaparoscópica de urgência

B) Manter cefepima e associar vancomicina oral

C) Piperacilina-tazobactam, jejum e suporte clínico

D) Colonoscopia com biópsia do ceco

---

24 Mulher de 34 anos, com retocolite ulcerativa extensa diagnosticada há 6 anos, em remissão clínica e endoscópica há 2 anos com mesalazina 4 g/dia, procura atendimento por 8 evacuações diárias com sangue, urgência e cólicas há 9 dias. Concluiu há 12 dias amoxicilina-clavulanato por 7 dias para sinusite. Nega viagens e uso de anti-inflamatórios. Temperatura de 37,8 °C, FC 94 bpm, PA 118/72 mmHg, abdome doloroso em fossa ilíaca esquerda, sem distensão. Hb 11,8 g/dL, leucócitos 14.200/mm³, PCR 48 mg/L, albumina 3,6 g/dL, calprotectina fecal 1.450 µg/g. Coprocultura negativa; GDH e toxinas A/B de Clostridioides difficile positivas nas fezes. Retossigmoidoscopia flexível: eritema, friabilidade e ulcerações rasas contínuas desde o reto, sem pseudomembranas (Mayo endoscópico 2); biópsias sem inclusões virais. Radiografia de abdome sem dilatação colônica. Além de manter a mesalazina, a conduta inicial mais adequada é:

A) Indução com infliximabe intravenoso

B) Metronidazol oral por 10 dias

C) Prednisona oral 40 mg ao dia

D) Vancomicina oral por 10 dias

---

25 Mulher de 71 anos, com DPOC grave (VEF1 de 32% do previsto) em oxigenoterapia domiciliar a 1 L/min, é trazida pelo SAMU por piora da dispneia e do escarro há 3 dias. Na ambulância recebeu máscara com reservatório a 15 L/min, mantida na chegada. Está alerta, orientada, conversando em frases completas, FR 24 irpm, FC 104 bpm, PA 138 × 82 mmHg, SpO2 99%, sem uso de musculatura acessória intenso e sem respiração paradoxal. Gasometria arterial com a máscara: pH 7,37, PaCO2 61 mmHg, PaO2 142 mmHg, bicarbonato 35 mEq/L. A gasometria de 2 meses atrás, em ar ambiente na consulta, mostrava PaCO2 de 54 mmHg e bicarbonato de 33 mEq/L. Radiografia de tórax sem consolidação nem pneumotórax. Já recebeu salbutamol e ipratrópio inalatórios e prednisona. Quanto ao oxigênio e à ventilação não invasiva, a conduta mais adequada neste momento é, respectivamente:

A) Titular para SpO2 88% a 92% / sem VNI agora

B) Suspender o oxigênio / sem VNI agora

C) Titular para SpO2 88% a 92% / VNI imediata

D) Manter a máscara com reservatório / VNI imediata

---

26 Homem de 38 anos, fisiculturista, procura o ambulatório por cefaleia holocraniana há 5 semanas, pior ao deitar e ao tossir, com escurecimentos visuais de segundos ao se levantar e zumbido pulsátil à direita. Usa por conta própria cipionato de testosterona 250 mg por semana há 8 meses, associado a oxandrolona. A esposa relata roncos altos com pausas respiratórias. IMC 31 kg/m², PA 138/86 mmHg, FC 72 bpm. Papiledema bilateral grau III e paresia do VI nervo à esquerda, sem outros déficits. Hemograma: hemoglobina 18,9 g/dL, hematócrito 57%, plaquetas 260.000/mm³. TC de crânio sem contraste e RM de encéfalo sem contraste: parênquima normal, sela parcialmente vazia e achatamento posterior dos globos oculares. O neurologista assistente registra 'hipertensão intracraniana idiopática em paciente obeso' e prescreve acetazolamida após a punção lombar com manometria, já agendada. O próximo passo mais adequado é:

A) Punção lombar com manometria

B) Venografia por ressonância magnética

C) Acetazolamida e perda de peso

D) Polissonografia de noite inteira

---

27 Mulher de 27 anos, 5 semanas após parto vaginal sem intercorrências, com pré-natal normal e sem pré-eclâmpsia, procura a emergência por astenia, edema e redução da diurese há 4 dias. Teve dois episódios de fezes amolecidas, sem sangue, na semana anterior. PA 168 × 104 mmHg, afebril, sem alteração neurológica. Hemoglobina 7,1 g/dL com esquizócitos, plaquetas 62.000/mm³, LDH 1.840 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo, creatinina 4,6 mg/dL, C3 58 mg/dL (90 a 180), C4 normal. O plantão iniciou plasmaférese diária com a hipótese de púrpura trombocitopênica trombótica; após 5 sessões, plaquetas de 70.000/mm³ e creatinina de 4,9 mg/dL. Chega então o resultado da atividade de ADAMTS13 colhida antes da primeira sessão: 64%. Pesquisa de Shiga toxina nas fezes negativa. O diagnóstico e a conduta mais adequada neste momento são, respectivamente:

A) SHU atípica / eculizumabe

B) PTT adquirida / caplacizumabe

C) SHU atípica / plasmaférese mantida

D) SHU por Shiga toxina / suporte

---

28 Homem de 38 anos tem o terceiro episódio, em 2 anos, de monoartrite aguda do joelho. A artrocentese mostra cristais romboides com birrefringência fracamente positiva, 18.000 leucócitos/mm³, Gram e cultura negativos. Radiografias: condrocalcinose meniscal bilateral e na fibrocartilagem triangular dos punhos. Relata cãibras frequentes e fadiga desde a adolescência; nega uso de diuréticos, laxativos ou álcool em excesso. PA 104 × 66 mmHg, sem hepatomegalia, pele sem hiperpigmentação. Sódio 138 mEq/L, potássio 2,9 mEq/L, bicarbonato 31 mEq/L, magnésio 1,1 mg/dL (referência: 1,7 a 2,4), cálcio 9,4 mg/dL, PTH 42 pg/mL, TSH normal. Ferritina 520 ng/mL (referência: 30 a 400) com saturação de transferrina de 29%, colhidas durante a crise. Cálcio urinário de 40 mg/24 h. A causa subjacente mais provável da doença por depósito de pirofosfato é:

A) Hemocromatose hereditária

B) Síndrome de Gitelman

C) Hiperparatireoidismo primário

D) Síndrome de Bartter

---

29 Homem de 66 anos, diabético há 12 anos, hipertenso e com angina estável controlada, usa metformina 850 mg de 12 em 12 horas, losartana 100 mg/dia, anlodipino 10 mg/dia, AAS 100 mg/dia, atorvastatina 40 mg/dia e pioglitazona 45 mg/dia, esta acrescentada há 4 meses por hemoglobina glicada de 8,4%. Nos últimos 3 meses ganhou 5 kg e notou edema de membros inferiores até os joelhos; a enfermeira da unidade atribuiu o edema ao anlodipino, que ele usa há 6 anos. Há 3 semanas tem dispneia aos esforços moderados e precisa de dois travesseiros para dormir. Ao exame: PA 138 × 84 mmHg, FC 88 bpm, SatO2 95%, turgência jugular a 45 graus, estertores crepitantes nas bases, terceira bulha e edema 2+/4 depressível. Creatinina 1,3 mg/dL (TFGe 58 mL/min/1,73 m²), potássio 4,6 mEq/L, NT-proBNP 2.100 pg/mL, hemoglobina glicada atual de 7,1%. Ecocardiograma: FE de 46%, sem valvopatia. Entre os medicamentos em uso, o que deve ser suspenso é:

A) Metformina

B) Losartana

C) Pioglitazona

D) Anlodipino

---

30 Mulher de 38 anos, técnica de enfermagem em hospital-dia de diabetes, é levada à emergência pela terceira vez em 2 meses com sudorese, confusão e glicemia capilar de 34 mg/dL, revertidas com glicose venosa. Não tem diabetes, nega etilismo, perda de peso ou cirurgia gástrica. O marido usa insulina glargina e metformina, e o pai, que mora com o casal, usa gliclazida. Na crise atual, antes da glicose: glicemia plasmática 38 mg/dL, insulina 42 µU/mL (esperado em hipoglicemia: abaixo de 3), peptídeo C 4,6 ng/mL (esperado: abaixo de 0,6), pró-insulina 12 pmol/L (esperado: abaixo de 5), beta-hidroxibutirato 0,1 mmol/L e elevação da glicemia de 38 mg/dL após 1 mg de glucagon. Anticorpos anti-insulina negativos. Tomografia de abdome com contraste, feita em outro serviço, sem lesão pancreática. A origem da insulina e o exame mais adequado a seguir são, respectivamente:

A) Exógena / insulina dosada por outro ensaio

B) Endógena / ecoendoscopia do pâncreas

C) Endógena / pesquisa de sulfonilureias no plasma

D) Exógena / observação sem acesso a insulina

---

31 Mulher de 66 anos, hipertensa em uso de hidroclorotiazida, é trazida pela filha por 5 semanas de apatia, esquecimento progressivo e episódios de desorientação. Nega febre, perda de peso, cefaleia intensa e vômitos. Sorologia para HIV não reagente. Exame: Glasgow 15, sem papiledema, sem déficit motor, Mini-Mental 21. A RM de crânio mostra lesão única de 3,2 cm no esplênio do corpo caloso, em contato com o ventrículo, com realce homogêneo pelo gadolínio, restrição à difusão e edema perilesional moderado, com desvio da linha média de 2 mm. A avaliação oftalmológica com lâmpada de fenda é normal. TC de tórax, abdome e pelve sem alterações; LDH 240 U/L. O plantonista prescreveu dexametasona 4 mg de 6 em 6 horas por causa do edema, ainda não administrada. A conduta mais adequada é:

A) Dexametasona e biópsia após reduzir o edema

B) Ressecção cirúrgica ampla da lesão

C) Radioterapia de crânio total empírica

D) Biópsia estereotáxica sem corticoide prévio

---

32 Homem de 41 anos vive com HIV há 8 anos, em uso regular de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, com carga viral indetectável e CD4 de 290 células/mm³ no último controle. Há 3 anos teve sífilis secundária, com VDRL de 1:128, tratada com penicilina benzatina 2,4 milhões UI em dose única, com registro de aplicação. Controles do VDRL: aos 6 meses, 1:8; aos 12 meses, 1:4; depois, 1:2, 1:4, 1:2 e 1:2 nos últimos 24 meses. Mantém parceria única estável, cujo teste rápido treponêmico do último mês foi não reagente, e usa preservativo de forma irregular. Nega cefaleia, alteração visual, zumbido ou perda auditiva; exame neurológico e fundoscopia normais, sem lesões cutâneas ou mucosas. Foi encaminhado pela unidade básica porque o VDRL 'continua reagente' e o teste treponêmico permanece reagente. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Penicilina benzatina em três doses semanais

B) Penicilina cristalina intravenosa por 14 dias

C) Manter apenas o seguimento sorológico

D) Punção lombar antes de decidir o retratamento

---

33 Homem de 67 anos, hipertenso e com fibrilação atrial em uso irregular de apixabana (última dose há 3 dias), foi visto bem pela esposa às 20h, quando foi deitar, e encontrado às 7h com afasia global e hemiplegia direita. Chega ao pronto-socorro às 8h: PA 176/98 mmHg, FC 96 bpm irregular, glicemia capilar 142 mg/dL, NIHSS 19. Creatinina 0,9 mg/dL, plaquetas 210.000/mm³, INR 1,1, TTPa normal. TC sem contraste: ASPECTS 8. Angiotomografia: oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda. RM imediata: lesão em difusão de 18 mL na ínsula e nos núcleos da base, já com hipersinal nítido no FLAIR na mesma área; perfusão com volume hipoperfundido (Tmax acima de 6 s) de 120 mL. Trombólise intravenosa e trombectomia mecânica estão, respectivamente:

A) Indicada / indicada

B) Indicada / contraindicada

C) Contraindicada / indicada

D) Contraindicada / contraindicada

---

34 Homem de 56 anos, com cirrose alcoólica Child-Pugh B, abstinente há 8 meses, em uso de espironolactona 100 mg, furosemida 40 mg e propranolol 40 mg ao dia, é internado por aumento do volume abdominal e edema de membros inferiores. Creatinina de 2,4 mg/dL (basal de 1,0 mg/dL há 3 meses), sem uso de anti-inflamatório ou contraste, sem diarreia nem sangramento. Afebril, PA 132/78 mmHg, FC 76 bpm. Paracentese diagnóstica com 60 polimorfonucleares/mm³. Os diuréticos foram suspensos e ele recebeu albumina 1 g/kg por 2 dias, sem queda da creatinina (2,5 mg/dL); a equipe registrou síndrome hepatorrenal e iniciou terlipressina. Sódio urinário de 8 mEq/L. Exame de urina: proteína 2+, 70 hemácias por campo, 80% dismórficas, com cilindros hemáticos; proteinúria de 1,8 g/24 h. C3 discretamente reduzido. Ultrassonografia: rins de 11 cm, sem hidronefrose. A causa mais provável da lesão renal é:

A) Nefrite intersticial aguda por diurético

B) Necrose tubular aguda isquêmica

C) Síndrome hepatorrenal com lesão renal aguda

D) Glomerulonefrite por IgA associada à cirrose

---

35 Homem de 67 anos, com miocardiopatia isquêmica (fração de ejeção de 35%) e taquicardia ventricular recorrente, usa amiodarona 200 mg ao dia há 14 meses, além de carvedilol, sacubitril-valsartana e espironolactona. Há 4 anos, ainda sem amiodarona, uma ultrassonografia mostrara bócio multinodular, com punções benignas e TSH normal. Há 5 semanas, perdeu 4 kg, a dispneia piorou e o cardiodesfibrilador deu dois choques apropriados. FC 104 bpm, PA 112 × 70 mmHg. TSH abaixo de 0,01 mUI/L, T4 livre 3,9 ng/dL (0,9 a 1,8), T3 total 260 ng/dL (80 a 200), TRAb negativo. Ultrassonografia com Doppler: tireoide aumentada, multinodular, com vascularização aumentada nos nódulos e no parênquima. Captação de iodo radioativo em 24 horas de 9%. O cardiologista não considera seguro retirar a amiodarona. O tratamento inicial mais adequado da tireotoxicose é:

A) Metimazol em dose alta

B) Suspensão da amiodarona isolada

C) Iodo radioativo em dose ablativa

D) Prednisona em dose moderada

---

36 Homem de 47 anos sabe ter valva aórtica bicúspide desde o serviço militar. A mãe conta que ele teve febre reumática aos 9 anos, com artrite migratória, e recebeu penicilina benzatina por alguns anos. Há 1 ano tem dispneia aos esforços moderados e palpitações ao deitar sobre o lado esquerdo. Ao exame: PA 158 × 46 mmHg, FC 74 bpm, pulsos amplos e de colapso rápido, oscilação da cabeça a cada batimento; ictus no 7º espaço intercostal, hiperdinâmico. Clique ejetivo, sopro diastólico aspirativo 3+/6 na borda esternal esquerda, com o paciente sentado e inclinado para a frente, e ruflar mesodiastólico 2+/6 no ápice, sem reforço pré-sistólico; B1 normofonética, sem estalido de abertura. Ecocardiograma: insuficiência aórtica grave por valva bicúspide, ventrículo esquerdo com diâmetro sistólico de 48 mm e FE de 56%, valva mitral de folhetos finos e sem fusão comissural. Durante a inalação de nitrito de amila, espera-se que o ruflar apical:

A) Aumente na inspiração profunda

B) Aumente na fase de esforço do Valsalva

C) Diminua de intensidade

D) Aumente de intensidade

---

37 Homem de 64 anos procura a unidade de saúde pedindo um exame para câncer de pulmão, porque um amigo da mesma idade acabou de receber esse diagnóstico. Fumou 2 maços por dia dos 18 aos 47 anos (58 maços-ano) e parou há 17 anos, sem recaída. Tem DPOC GOLD 2 em uso de tiotrópio, sem exacerbações no último ano, e o pai morreu de câncer de pulmão aos 70 anos. Nega tosse nova, hemoptise, perda de peso ou dor torácica; a dispneia aos grandes esforços é a mesma de anos. Exame: IMC 27 kg/m², FR 16 irpm, SatO2 95% em ar ambiente, murmúrio vesicular difusamente diminuído, sem baqueteamento digital nem linfonodos palpáveis. Radiografia de tórax de 1 ano atrás com hiperinsuflação, sem nódulos. Segundo a recomendação da USPSTF (2021), a conduta mais adequada quanto ao rastreamento do câncer de pulmão é:

A) TC de baixa dose anual

B) TC de baixa dose por 3 anos

C) Radiografia de tórax anual

D) Não indicar o rastreamento

---

38 Homem de 69 anos, ex-tabagista (30 maços-ano), contador aposentado, refere dispneia progressiva e tosse seca há 18 meses. Usa losartana e atorvastatina; nunca usou amiodarona, nitrofurantoína ou metotrexato. Nega pássaros, mofo em casa, edredom ou travesseiro de penas, umidificador e trabalho com poeiras. Nega Raynaud, artrite, rigidez matinal, fraqueza muscular, fissuras nas mãos e disfagia. Ao exame, SpO2 93% em repouso, baqueteamento digital e estertores em velcro nas bases, sem lesões cutâneas. FAN 1:80, padrão nuclear pontilhado fino; fator reumatoide, anti-CCP, anti-Ro, anti-Scl-70 e painel de antissintetases negativos; CPK normal. TC de tórax de alta resolução: reticulação subpleural de predomínio basal com faveolamento subpleural basal com bronquiectasias de tração, sem vidro fosco extenso, sem micronódulos e sem atenuação em mosaico. CVF 68% e DLCO 49% do previsto. A discussão multidisciplinar não identificou causa secundária. A conduta mais adequada é:

A) Biópsia pulmonar cirúrgica

B) Micofenolato de mofetila

C) Prednisona, azatioprina e N-acetilcisteína

D) Nintedanibe ou pirfenidona

---

39 Mulher de 52 anos, não tabagista, apresenta há 5 meses dispneia progressiva, tosse seca e febre baixa intermitente, com artralgia simétrica de punhos e metacarpofalangeanas e fenômeno de Raynaud há 1 ano. Nega fraqueza, disfagia ou lesões em pálpebras. Exame: SpO2 de 91% em ar ambiente, estertores em velcro nas bases, força grau 5 nas cinturas, descamação fissurada nas bordas laterais dos dedos indicadores, sem espessamento cutâneo proximal e sem esclerodactilia. CK 160 U/L (referência: até 170), aldolase normal. Fator reumatoide 48 UI/mL (referência: até 14), anti-CCP não reagente, FAN 1:160 com padrão citoplasmático pontilhado fino denso, anti-Jo-1 não reagente, anti-Ro52 reagente, anti-Scl-70 não solicitado. TC de tórax: vidro fosco e reticulado basal com consolidações periféricas, poupando a região subpleural. O exame com maior rendimento para definir o diagnóstico é:

A) Painel ampliado de anticorpos antissintetase

B) Biópsia de quadríceps guiada por ressonância

C) Anti-Scl-70 e anticentrômero

D) Biópsia pulmonar cirúrgica

---

40 Homem de 71 anos, com creatinina de 1,0 mg/dL há 6 meses, faz uso de omeprazol 40 mg/dia, iniciado há 10 semanas por dispepsia, além de losartana e atorvastatina há anos. É encaminhado por creatinina de 3,4 mg/dL em exame de rotina; está assintomático. Nega febre, exantema, artralgia, contraste recente e anti-inflamatórios. PA 132 × 80 mmHg, sem edema, mucosas úmidas, sem hipotensão postural. Hemograma com 210 eosinófilos/mm³. Urina: densidade 1,010, proteína 1+, 25 leucócitos e 3 hemácias por campo, cilindros leucocitários; urocultura negativa. Proteinúria de 24 horas de 0,6 g, fração de excreção de sódio de 2,8%, complemento normal e ANCA negativo. Ultrassonografia com rins de 11 cm, sem hidronefrose. O diagnóstico mais provável é:

A) Nefrite intersticial aguda

B) Necrose tubular aguda isquêmica

C) Pielonefrite aguda bilateral

D) Lesão pré-renal pela losartana

---

41 Mulher de 24 anos, estudante, procura a emergência por tosse seca há 9 dias, cefaleia, dor de garganta, otalgia direita e febre baixa; o irmão, com quem divide o quarto, teve quadro semelhante há 3 semanas. Está em programa de substituição com metadona 110 mg/dia há 1 ano, sem uso de outras substâncias; não tem alergias. Ao exame, temperatura 37,8 °C, FR 20 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, PA 118/72 mmHg, estertores finos nas bases e vesículas hemorrágicas na membrana timpânica direita. Radiografia: infiltrado reticular bilateral nas bases. Hemoglobina 10,1 g/dL, reticulócitos 6%, bilirrubina indireta 2,4 mg/dL, LDH 520 U/L; teste de antiglobulina direto positivo para C3d e negativo para IgG. Ureia e creatinina normais; beta-hCG negativo. Eletrocardiograma: ritmo sinusal, QTc de 512 ms. Será tratada em domicílio. O antimicrobiano isolado mais adequado é:

A) Doxiciclina

B) Azitromicina

C) Levofloxacino

D) Amoxicilina

---

42 Homem de 74 anos, diabético e hipertenso, em uso de metformina, losartana e AAS 100 mg/dia, procura a emergência por aumento de volume doloroso na coxa direita há 4 dias, sem trauma, e equimoses extensas nos braços há 2 semanas. Nunca sangrou de forma anormal: fez herniorrafia aos 60 anos e três extrações dentárias sem intercorrência. Sem hepatopatia e sem história familiar de sangramento. Exame: FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg, coxa direita tensa, com equimose que se estende ao joelho, pulsos distais presentes. Exames: Hb 7,6 g/dL (era 13,1 há 3 meses), plaquetas 236.000/mm³, TP com INR 1,0, fibrinogênio 390 mg/dL, TTPa 81 s (controle 30 s). No teste da mistura com plasma normal (1:1), o TTPa cai para 33 s na leitura imediata e, após incubação por 2 horas a 37 °C, sobe para 62 s. Fator VIII 2%, fator IX 96%, fator XI 88%. Quanto ao diagnóstico e ao tratamento hemostático, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Hemofilia A leve congênita / fator VII ativado recombinante

B) Hemofilia A adquirida / fator VII ativado recombinante

C) Hemofilia A leve congênita / concentrado de fator VIII

D) Hemofilia A adquirida / concentrado de fator VIII

---

43 Homem de 61 anos, pedreiro aposentado, diabético em uso de metformina, é encaminhado com hipótese de esclerose lateral amiotrófica por fraqueza e atrofia das mãos e dos braços há 10 meses, fasciculações em bíceps e deltoides e marcha 'dura', com duas quedas no último mês. Relata choque que desce pela coluna ao fletir o pescoço e urgência miccional recente. Exame: atrofia de interósseos e de bíceps bilateral, reflexos bicipitais abolidos e tricipitais vivos, sinal de Hoffmann bilateral, hiper-reflexia patelar e Babinski bilateral; vibração abolida nos tornozelos; língua sem atrofia nem fasciculações, fala e deglutição normais. B12 450 pg/mL, HbA1c 7,0%. RM cervical: estenose de C4 a C6 com hipersinal medular em T2 em C5. ENMG: desnervação ativa e crônica restrita aos miótomos de C5 a C7, com língua, paravertebrais torácicos e membros inferiores sem desnervação. A conduta mais adequada é:

A) Riluzol e acompanhamento multiprofissional

B) Colar cervical e fisioterapia por 3 meses

C) Repetir a eletroneuromiografia em 6 meses

D) Descompressão cirúrgica cervical

---

44 Mulher de 52 anos tem fibrilação atrial paroxística diagnosticada há 8 meses, com três crises sintomáticas desde então, a última de 30 horas, revertida na emergência com medicação venosa. Usa metoprolol 50 mg de 12 em 12 horas, sem efeitos adversos, e continua com palpitações que a afastaram do trabalho. Não tem hipertensão, diabetes, doença vascular ou insuficiência cardíaca; a mãe teve AVC aos 81 anos. Bebe uma taça de vinho nos fins de semana. Ao exame: PA 122 × 76 mmHg, FC 64 bpm, ritmo regular, sem sopros. TSH 1,8 mUI/L, função renal e hepática normais. Ecocardiograma: FE de 64%, septo e parede posterior de 9 mm, átrio esquerdo de 37 mm, valvas normais. Teste ergométrico máximo sem isquemia. Ela prefere tratamento medicamentoso a ablação neste momento. Para prevenir novas crises e quanto à anticoagulação, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Amiodarona / apixabana

B) Amiodarona / sem anticoagulação

C) Propafenona / apixabana

D) Propafenona / sem anticoagulação

---

45 Homem de 61 anos, com artrite reumatoide soropositiva e erosiva há 19 anos, tratada de forma irregular, usa naproxeno 500 mg duas vezes ao dia há anos e prednisona 7,5 mg/dia. A PCR se manteve entre 40 e 80 mg/L em todas as dosagens dos últimos 5 anos. Há 3 meses, edema progressivo de membros inferiores e diarreia crônica sem sangue. PA 112 × 70 mmHg, edema até a raiz das coxas, fígado palpável a 3 cm do rebordo costal. Albumina 2,1 g/dL, proteinúria de 9,6 g/24 h, sedimento urinário sem hematúria e sem leucocitúria, creatinina 1,6 mg/dL, C3 e C4 normais, FAN não reagente. Eletroforese de proteínas sem pico monoclonal, imunofixação negativa e relação kappa/lambda de cadeias leves livres normal. Ultrassonografia: rins de 12,8 e 13,1 cm, com ecogenicidade aumentada. Na biópsia renal, o achado esperado é:

A) Fusão difusa de podócitos sem depósitos

B) Depósitos subepiteliais com espículas na prata

C) Depósitos mesangiais dominantes de IgA

D) Depósitos amorfos com birrefringência verde-maçã

46 Mulher de 46 anos, com transtorno bipolar tipo I, está estável há 5 anos com carbonato de lítio 900 mg ao dia (litemia 0,8 mEq/L), introduzido após falha prévia com valproato e com lamotrigina. Há 4 meses refere cansaço, ganho de 5 kg, constipação, pele seca e desânimo, e a família teme uma nova fase depressiva. Nega mudança de dose, diuréticos ou anti-inflamatórios. PA 128 × 84 mmHg, FC 58 bpm, tireoide discretamente aumentada, difusa, indolor, reflexos com relaxamento lentificado. TSH 11,8 mUI/L (0,4 a 4,5), T4 livre 0,7 ng/dL (0,9 a 1,8), anti-TPO positivo, cálcio 9,6 mg/dL, sódio 139 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. O residente de psiquiatria, lembrando que o lítio é bociogênico, propõe trocá-lo. A conduta mais adequada é:

A) Levotiroxina, mantendo o lítio

B) Repetir TSH e T4 livre em 8 semanas

C) Reduzir o lítio e repetir o TSH

D) Trocar o lítio por valproato

---

47 Mulher de 23 anos, estudante de nutrição, é levada pela mãe por fraqueza e palpitações há 1 semana. Diz que segue dieta restritiva por conta própria e nega vômitos, laxantes e diuréticos. IMC 18,9 kg/m², PA 100 × 62 mmHg, FC 104 bpm. Hipertrofia bilateral de parótidas e erosão do esmalte nas faces palatinas dos incisivos; sem lesões no dorso das mãos. Exames: Na 137 mEq/L, K 2,6 mEq/L, Cl 88 mEq/L, HCO3 34 mEq/L, pH 7,51, Mg 2,0 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Urina isolada: Na 72 mEq/L, K 38 mEq/L, Cl 7 mEq/L, pH 7,8. A pesquisa de diuréticos na urina foi solicitada e está pendente. A causa mais provável da hipocalemia é:

A) Abuso de laxativos estimulantes

B) Vômitos autoinduzidos

C) Uso oculto de diurético tiazídico

D) Síndrome de Bartter

---

48 Homem de 38 anos, com diagnóstico de HIV há 2 meses (CD4 de 45 células/mm³), em uso de TARV há 5 semanas, tem placas violáceas nos membros inferiores, cuja biópsia mostrou sarcoma de Kaposi. Há 3 semanas apresenta dispneia progressiva, febre baixa noturna e perda de 4 kg. O irmão, com quem mora, terminou há 4 meses o tratamento de tuberculose pulmonar. Temperatura 37,9 °C, FR 26 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, abolição do murmúrio no terço inferior do hemitórax direito. TC de tórax: derrame pleural direito volumoso, sem espessamento pleural nodular, sem massa mediastinal, sem linfonodomegalias e sem lesões parenquimatosas. Toracocentese: exsudato serossanguinolento, LDH 1.450 U/L, proteína 4,8 g/dL, ADA 58 U/L (referência: até 40), teste rápido molecular para tuberculose não detectado. Citologia: grandes células atípicas de aspecto plasmablástico; imunofenotipagem com CD45 e CD138 positivos, CD20 e CD79a negativos, e marcação nuclear para LANA-1 (HHV-8). O diagnóstico mais provável é:

A) Linfoma primário de efusão

B) Tuberculose pleural

C) Sarcoma de Kaposi pleural

D) Linfoma de Burkitt

---

49 Homem de 27 anos, há 5 meses com pápulas e vesículas agrupadas, intensamente pruriginosas, simétricas em cotovelos, joelhos, região sacral e couro cabeludo, a maioria escoriada. Usou corticoide tópico de alta potência sem melhora. Nega diarreia, dor abdominal ou perda de peso, e não usa medicações. Tem tireoidite de Hashimoto em levotiroxina. Ao exame, bom estado geral, sem lesões em mucosas, sinal de Nikolsky negativo. Hb 12,1 g/dL, VCM 76 fL, ferritina 9 ng/mL; IgA sérica total normal; antitransglutaminase IgA de 86 U/mL (referência abaixo de 10). Uma biópsia de vesícula íntegra mostrou clivagem subepidérmica com microabscessos de neutrófilos nas papilas dérmicas, laudada como dermatose bolhosa subepidérmica a esclarecer. Para confirmar a natureza da lesão cutânea, o exame mais adequado é:

A) Biópsia duodenal com quatro fragmentos

B) Anticorpos séricos anti-BP180 e anti-BP230

C) Imunofluorescência direta da pele perilesional

D) Imunofluorescência direta da vesícula

---

50 Homem de 67 anos, ex-tabagista (45 maços-ano, parou há 2 anos), procura o ambulatório para iniciar tratamento após espirometria solicitada pelo clínico. Nos últimos 12 meses foi duas vezes à UPA por piora da tosse e da dispneia com escarro purulento, tratado com prednisona oral e antibiótico, sem internação. Teve pneumonia tratada ambulatorialmente há 5 anos, sem novos episódios. Entre as crises diz que se sente bem: caminha 3 km por dia, mMRC 1 e CAT 9. Usa apenas anlodipino. Ao exame, FR 16 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, murmúrio vesicular discretamente reduzido, sem sibilos. Espirometria pós-broncodilatador: VEF1/CVF 0,58 e VEF1 de 64% do previsto, sem resposta significativa ao broncodilatador. Hemograma colhido fora de exacerbação, sem corticoide há 4 meses: eosinófilos 340/mm³. Radiografia de tórax com hiperinsuflação, sem consolidação. O tratamento inalatório de manutenção mais adequado para iniciar é:

A) LAMA isolado

B) LABA associado a LAMA

C) LABA, LAMA e corticoide inalatório

D) LABA associado a corticoide inalatório

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado R03

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										